

pr oubaha 1 partie 2

Maladie Céliaque. Oui. Vidéo-cancer.

Vidéo-cancer clinique. Vous avez vu que je n'ai pas mis ni adrénal-carcinome, ni l'IA-COV, ni rien du tout. J'ai mis le cancer clinique.

Est-ce qu'on a le droit de déterminer chez cette patiente-là qu'il y a des douleurs et qu'il y a de la constipation ? C'est vrai que ça a évolué depuis 5 ans, mais quand même, depuis 4 mois, c'est devenu assez asymptomatique et il n'a changé. Est-ce que je suis en droit de retenir sans parler du cancer chez cette patiente-là ? Alors, vous voyez la réponse ? C'est un trouble fonctionnel intestinal, oui, mais je ne suis pas en droit d'éliminer le cancer clinique sur cette vignette-là. La maladie nocturne, ce n'est pas ça, parce que c'est surtout du mal diarrhée, l'attranchement, je ne vais pas en parler.

Les épisodes de diarrhée à répétition, l'opération de l'étagement, vous ne savez pas. La maladie stérile, là aussi, c'est surtout du mal diarrhée, plus que la constipation et les douleurs autochtones. L'écolique, l'hépatique, ce n'est pas le tableau, parce qu'on a précisé que cellulologiquement, c'est des douleurs diffuse et atypiques.

Par contre, l'écolique épatiche, elle a une destitution cellulologique bien plus. Chez cette patiente, quand je vous dis qu'elle est impossible, je veux dire que oui, c'est une théorie et que je ne veux pas éliminer le cancer, même si l'état général conservait une pathologie sexuelle. Même s'il n'y a pas d'apparition de l'état général, c'est-à-dire que la patiente a le droit de dire qu'elle ne veut pas de pathologie cancéreuse.

En l'absence d'apparition de l'état général, la patiente peut, par conséquent, avoir une constipation d'origine obstructive chez cette patiente. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? En avance ? Parfait. Bon.

Maintenant, j'ai la patiente devant moi. Je sais qu'elle a une symptomatologie qui est plutôt en faveur du TFI, mais je n'ai pas suffisamment d'arguments pour éliminer la pathologie génétique, donc je vais demander des examens contrairement. Est-ce que je vais demander une NFS, un SRP, une recherche d'une dysthyroïdite, une recherche d'une maladie céliaque, une échographie abdominale, ou une coloscopie ? Allez-y.

La parole est à vous. Bon. Il y a des gens qui vont demander une NFS, un SRP, il y a des gens qui vont demander la coloscopie, et il y a des gens qui vont demander une NFS, un SRP et une coloscopie.

Vous avez été influencé par ce que j'ai dit. Alors, si on revient à notre cas clinique, vous voyez qu'à la lecture du cas clinique, j'ai beaucoup d'arguments en faveur de la TFI. Donc, mon premier défi, c'est la TFI.

Mais, je ne peux pas éliminer le cancer clinique. Donc, j'ai tranché les deux. En sachant que je vais surtout chercher la TFI tout en éliminant le cancer clinique.

Parce que si vous vous rappelez de votre cours, on a dit qu'il n'y avait pas d'examen complémentaire capable de confirmer une TFI. Mais, le but est de demander des examens complémentaires c'est surtout d'éliminer une autre pathologie qui organise, qui est reléverait d'un traitement spécial. C'est pour ça que, quand je vous ai demandé des examens complémentaires, vous avez eu des gens qui m'ont coché rien que la coloscopie.

C'est ça ? Bon. Alors, sachez que Sachez que on va faire quand même un bilan biologique standard. On est vers CRP.

La recherche de la dysthéroménie, non, on ne va pas la demander chez nos patients parce que la place que j'ai demandé au bilan de dysthéroménie, c'est surtout qu'on aura un syndrome de l'intestin héritable dans sa forme diarrhélique. La recherche de la maladie céliaque, c'est quand on a également un syndrome de l'intestin héritable avec la forme diarrhélique ou alors si on est dans un pays ou dans une population où la fréquence de la maladie céliaque est supérieure à 1%. Donc, on ne va pas demander la recherche de la maladie céliaque.

L'échographie systématique, elle est inutile, il faut la déléguer parce que elle ne permet pas de trouver un biologique fonctionnel. Maintenant, la coloscopie. La coloscopie, elle a des indications recommandées qui sont l'apparition des symptômes à précédent temps, ce n'est pas le cas de notre patient.

C'est les antécédents familiaux de cancer. Ce n'est pas le cas de notre patient. C'est la recherche d'une polypose microscopique, mais la polypose microscopique, c'est chez les patients qui ont une diarrhée.

Notre patient a surtout de la constipation. C'est la découverte du méiorage microscopique, et il faut savoir que même la mise en évidence d'un coup, il devait se faire du coup, elle est le premier point. C'est pour ça que la hiérarchisation des bilans complémentaires est importante.

Pour redemander un bilan standard et la coloscopie, on va la demander en fonction des résultats de bilan standard et en fonction de la réponse thérapeutique de notre patient. On va d'abord demander un bilan d'objectifs et de bénéfices et un bilan informatif. Si j'ai une anémie, si j'ai un aneurysme inflammatoire, un CRP élevé, c'est là que je vais faire la coloscopie.

Mais sinon, je ne vais pas la demander d'anglais. Je vais la garder, je vais la faire chez cette patiente, mais je vais la demander en fonction des résultats du bilan du bilan standard de ma patiente. Pourquoi ça ? Parce que la patiente est remise sous les critères de Rome 4, donc j'ai retenu le diagnostic positif sur la clinique.

Il n'y a pas d'examen typique, mais je vais rechercher les signes d'alarme clinique et biologique.

Je vais demander la biologie standard. Si j'ai des signes d'alarme, c'est là que je vais compléter par une endoscopie digestive qui a les mêmes indications pour la population générale.

Comme on a dit, les dysthéroïdes et la maladie séniale, c'est quand le patient a de la diarrhée. Par contre, pour ce qui est d'épigéographie standard et d'école fonctionnelle, ils ont vraiment peu de place pour les moyens diagnostiques dans ce cadre. D'accord ? est-ce qu'il y a des problèmes ? Madame, en ce qui concerne la transcription, en ce qui concerne l'hypothérapie et la gestion de la situation, je ne peux pas demander un bilan thérapeutique.

Alors, on dirait qu'il y a des problèmes dans la population, mais en général, il n'y a pas de situation isolée. Il peut être associé chez ce patient, notamment le ralentissement psychologique, le ralentissement des côtes. Il y a des patients qui ont une certaine sensation de froid.

Il y a des patients qui vont avoir du myxélène, qui vont avoir des problèmes du visage, de la dépilation de la queue de sourcil. Donc, en général, il y a un cortège. Donc maintenant, rechercher une dysthéroïde, c'est certain, c'est pas le... On recherche surtout en cas de diarrhée, mais en cas de constipation, on ne demande pas la DSH en premier.

Maintenant, si tu as des signes d'appels cliniques qui peuvent t'orienter vers une pathologie endocrinienne, oui, notamment une hypothérapie qui peut l'appeler. On revient à notre cas clinique. Normalement, c'est un malade, on en a bien précisé uniquement et on ne pratiquera pas de matière spéciale.

Alors, il y a votre mademoiselle qui dit, est-ce qu'on demande la DSM, même s'il n'y a pas de signes cliniques, oui, on va la demander chez ses patients, parce que tout simplement, les signes cliniques de l'anémie, les signes cliniques de l'anémie, je réponds juste avant d'arrêter ça, les signes cliniques de l'anémie n'apparaissent que vraiment quand on a une anémie à cette proportion pendant cette expiration. Là, c'est pour une DSM, c'est-à-dire qu'on a une relation avec une perte très importante. Parfois, on peut demander à la DSM de rechercher des signes d'anémie aussi en faveur du plan inflammatoire.

Les signes inflammatoires sont souvent en partie du plan inflammatoire. Ça peut nous aider, même en l'absence de signes cliniques. Alors, il y a votre mademoiselle qui pose la question de pourquoi l'association avec des symptômes, avec des monstres de constipation est aussi valable.

Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle des endométrioses qui peuvent donner parfois des douleurs abdominales, et pour l'endométriose, c'est des douleurs qui vont survivre au moment de la constipation et qu'on peut rechercher ça. Dans ce cas, c'est que l'ADN, c'est tout et unique et c'est plutôt l'ADN monoclonale digestive qui a un comportement spécifique. C'est pour ça que vous avez l'association des symptômes avec les monstres de constipation.

Vous devez aussi savoir que les troubles fonctionnels intestinaux peuvent représenter des piques douloureuses ou des manifestations, une aggravation de la manifestation, une tension du signe.

Et comme on a dit, les défis restent à diagnostiquer ensemble. Si j'ai un cortège de signes et que j'ai une ambiance qui me font suspecter d'endométriose, il faut d'abord éliminer l'endométriose avant de dire que ce n'est plus le cortège.

D'accord ? Alors, Mlle Mikan, qu'est-ce que c'est faire ? Alors, est-ce que pour les autres cours, notamment la diversiculose, notamment, même les cours dont on vient de parler, parce que là, moi, je fais juste des exemples pour vous discuter, est-ce que vous avez des soucis avec les autres cours que j'ai posé sur la plate-forme ? Normalement, pour moi, j'ai un monstre pour proposer, mais j'ai une réponse sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos vues ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ou qui nécessite une vraie explication ? Parce que je ne sais pas comme ça aujourd'hui. Si c'est clair, c'est clair.

Mais après, s'il y a des soucis, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ? Oui, oui, oui. Donc, c'est des caractéristiques qui ne sont pas forcément constructives.

C'est plutôt permanent. Donc, il y a souvent l'association avec, parfois, des interventions qui ne peuvent pas exister. Il y a parfois l'association avec une anémie.

C'est-à-dire que, comme ça, on a demandé la négligence même chez cette patiente. Mais, deux conseils inconnus. Ça dépend de l'intégration.

Ça dépend de son alimentation. Parfois, c'est une constipation constructive. Parfois, si les dégâts sont un peu liquides, ou même sans limite, le patient peut dire qu'il n'est pas constipé.

C'est-à-dire qu'il est en fait sans alimentation. Et ça peut prendre un rapport intermédiaire. C'est vrai que le caractère intermédiaire peut être important pour le défi.

Mais le défi reste un diagnostic de l'organisme. Au moindre doute de diagnostic d'organicité d'une origine organico-syndrome qui représente l'organisme, vous devez obligatoirement éliminer une origine organique. Donc, c'est pour ça que, même si les critères sont plutôt en faveur du défi, sur cette patient, c'est un bon défi.

Mais, si j'ai mis une ancienne colique, ce n'est pas pour vous annuler. C'est pour montrer qu'il faut nous garder en tête qu'il ne faut pas compter sur vous. Vous devez pouvoir bien dénoncer votre patient.

Si on était sûrs à 100% que c'était un défi, normalement, il n'y a même pas d'indication à demander à l'ANFS et à l'ASR que c'est un défi. C'est ce que j'ai dit, mais maintenant, comment être sûrs que c'est un défi avec un minimum d'exploration ? Donc, on doit avoir un maximum d'arguments pour dire qu'il n'y a pas le dossier d'avoir ni clinique, ni biologique avant de faire la procédure. D'accord, mademoiselle Ragnard ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que je vous ai répondu ? Merci.

Alors, le cours de la liberté de dose, est-ce que c'est clair ? Alors, pour mademoiselle Marois, ce qui me donne le doute, ce n'est pas l'entièrement pénible de la patiente. Notamment le clinique, il est très rassurant chez cette patiente, mais je ne peux pas dire à 100% rien, monsieur Ragnard, sans m'aider au moins par un peu. Dites-lui, il n'y a rien à savoir, d'accord ? Il est en train d'avoir une attitude positive, conscience.

Moi, si j'ai mis ça, c'est juste pour préciser que c'est un bien de s'élever d'une condition, d'une condition. D'accord ? Parfait. Alors, pour les autres, est-ce que les cours sont clairs ? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une explication particulière, même qu'en dehors de ces deux cas pénibles ? Là, c'est juste pour discuter, pour ne pas laisser la discussion ouverte.

C'est juste que j'avais préparé ces deux situations pénibles pour qu'on puisse redéfinir un peu sur le cours qu'on a mis sur le plateau. Sur la diapositive précédente, laquelle ? Alors, c'est quel diapositive que vous voulez, mademoiselle, décider ? Est-ce que celle que j'ai mis pour les examens complémentaires ou celle qui résume ? Parce que là, je suis reconnue sur le résumé. Donc, pour résumer, pour diagnostier les examens complémentaires, pour rechercher ces données-là, ou alors c'est la diapositive qui parle des examens ? C'est celle-là que vous voulez ? Ça va ? Alors, s'il n'y a pas de questions, vous verrez peut-être.

Si vous n'avez plus de questions, si c'est clair. C'est toi aussi. Est-ce qu'on a fait la pause complète, ou non ? Alors, sur cette question, on n'a pas fait de pause complète.

On a fait l'agglomération pour consommer et la CV. Et vu que l'agglomération pour consommer est nécessaire, il est sans doute normal. On a traité, on n'a pas fait de pause complète, mais on a surveillé normalement au bout de 2-3 mois en ré-évaluant avec une bonne réponse clinique, on ne fait rien.

Avec une moins bonne réponse ou une récurrence en arrêt de traitement, on demande la pause complète. Ça va ? Est-ce que c'est clair ? Et cette patiente à 45 ans, à non plus 50 ans, j'aurais fait la pause complète. Alors, là, quel traitement on a donné ? Donc, pour cette patiente, on a essentiellement donné... D'ailleurs, j'avais préparé le traitement, le cas clinique, où j'ai demandé de le faire, pour ne pas faire trop longtemps.

C'est vrai que, bon, la proposition chez cette patiente, c'est d'avoir des règles d'hygiénopathie, une gravité et ça devrait être une habitude de vie chez elle, les aliments qu'elle prend, la façon dont elle prend ses aliments, les poissons, tout ça. Donc, c'est comment sont les règles que je lui ai dit qu'il faut donner à notre patiente. Après, vu qu'elle a de la douleur et qu'elle a de la constipation, on va donner des anticipations du grand âge de l'enfant.

Et là, d'abord, quand il y a une constipation, on va lui donner des gestes qui peuvent avoir des accents courts et des laxatives très légers et aux queues courtes. On ne va pas donner des laxatives aux queues longues, c'est juste le temps pour que les régimes alimentaires, que les

règles hygiénographiques fassent effet et que la malade essaye d'adapter son alimentation pour avoir un transit normal. Donc, on va donner tout d'abord ça.

Il y a certaines personnes qui peuvent aussi indiquer chez cette patiente qu'il y a trop d'une type, mais il faut d'abord donner les règles hygiénographiques quand il se passe du tractionnement et laxatives qu'on peut lui donner chez cette patiente. C'est ça qu'ils répondent. Ça va ? Bon, alors, une question ? Donc, j'espère que ça a été un peu bénéfique, ça vous a permis un peu de revoir qu'il ne serait-ce que les grandes lignes et de vous entraîner un peu sur les 4 lignes et les 5 lignes dans une diverticulose colline.

Est-ce que cela va nécessiter de se repenser à ce moment ? Pas du tout, mademoiselle. La diverticulose colline n'est pas une maladie, c'est une anomalie anatomique. Ce patient, on ne va pas le surveiller de façon particulière à cette patiente ni par voie ni même par des explorations non logiques à la patiente.

Mais par contre, on va insister sur d'abord une éducation avec un régime riche en fibres et lutter contre la constipation. De deux, pour éduquer votre patient, quant aux complications éventuelles de sa diverticulose colline, et c'est là que vous devez le revoir en vous précisant pour votre patient si vous présentez de l'hémorragie ou d'une âgée, si vous présentez des signes de péritonite, si vous présentez de l'hémorragie, notamment à titre de rectorragie, vous devez consulter, oui, mais vous devez aussi dire au médecin chez qui vous allez consulter que vous êtes porteur de diverticulose colline puisqu'on sait que la diverticulose peut se compliquer de diverticulite, elle peut se compliquer, bien sûr, avec les différents symptômes de diverticulite, aussi de fistulisation, d'abcès de diverticulère, de péritonite si la perforation est importante, elle peut se compliquer d'une hémorragie diverticulaire, donc c'est ce qu'il faut, c'est sûr, donc l'éducation de votre patient et de le sensibiliser quant aux complications d'hémorragie qui vont vous faire rendre à ce malade dans ce qu'on appelle la maladie de diverticulite, la diverticulose colline. Avec ce, ça ne nécessite pas d'urgence particulière.

D'accord ? Est-ce que je vous ai répondu, mes amis ? Bon. Merci à vous, donc si les autres n'ont pas de questions, merci, et on finit la réunion. Voilà.

Je vous libère. Et bonne continuation. Donc on finit la réunion et je vous dis bonne continuation.